

07

Tumeurs mélanocytaires

Kératome = 85% + peau / Basal / diff. de Kératome

Mélanocyte
↳ mélanine (pigment UV)
↳ Tumeur Née / Basal

⚠ Tumeurs cutanées ≠ tumeurs
Hypopigmentation Kératocytaires

NAEVUS NAVOCELLULAIRE / MÉLANOCYTAIRE

Tumeurs bénignes

Surface lisse, un peu surélevée, papillomateuse, plane

Regroupement en
thèques ou nappes

Arros. bien individualisé

en creux / Kératite diffuse

Tumeurs malignes au niveau de la peau (+++), des
muqueuses, choroïde oculaire ou méninges

④ Principaux types

Mélanome superficiel
extensif

Le + fréquent

Mélanome nodulaire

Mélanome de Dubreuil

Mélanome acral
lentigineux

Major types of melanoma



Superficial spreading melanoma



Nodular melanoma



Lentigo maligna melanoma



Acral lentiginous melanoma

Dubreuil

MÉLANOME

> 45 ans

Critère de classification
macroscopique (ABCD)

Asymétrie / Bord / Couleur / Diamètre
irrégule / irrégulier / grand

(c'est) l'avis pour les hommes - Régularité / Hémorragie / Stable

2 stades d'évolution

Initial Horizontal

épidermiques ("à côté")

Vertical

enfoncé de l'épiderme → osseux (cancer)

Pronostic

Extension en profondeur
(indice de Breslow)

+ Mélanomes

Grande Histiocytose FNCLCC (1-33):

- degré d'atypie
- cellules multiples
- population réséc



Fibrome Muc = Molluscum Pseudolux
... Bénin



Molluscum Contagiosum
... POX Virus



Fibrose Rétractile de l'Aponévrose
P. Local

TUMEURS CONJONCTIVES

Fibrome

Bénin, évolution lente

Composition : fibroblastes + fibres de collagènes en faisceau,

Plasma Endothé

Multifocales, évolutives et développées à partir des aponévroses

Tumeurs intra p
La Infection p - no
La Nouvelle p - p (hyperthick)

Fibromatose

Maladie de Dupuytren

Tumeur desmoïde

Prolifération fibro et myoblastique
→ Production collagène hyper (type de tumeur)

Très mal limitée et envahissante, malignité intermédiaire

Tumeur fibreuse solitaire

Dermatofibrosarcome de Darier et Ferrand

Malignité intermédiaire

Fibrosarcome

Malin

Atypie cytonucléaire, cellules dans tous les sens

TUMEURS ADIPEUSES

Lipomes

Fréquents et superficiels

Variantes : angioliipome et lipome à cellules fusiformes



Jeune - Femme

Liposarcomes

Liposarcome bien différencié : tumeur lipomateuse atypique "lipoma-like"

Souvent bien limité, parfois plurinodulaire

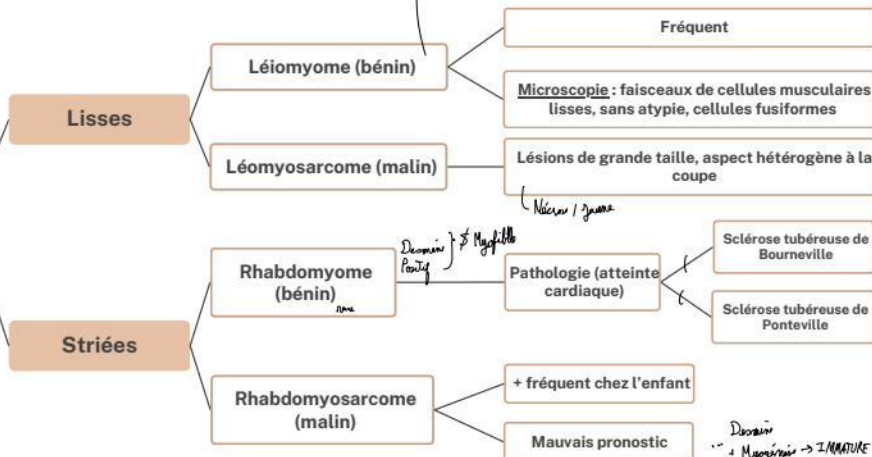
Amplification de MDM2

Liposarcome dédifférencié

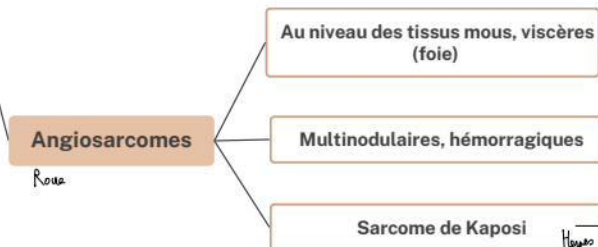
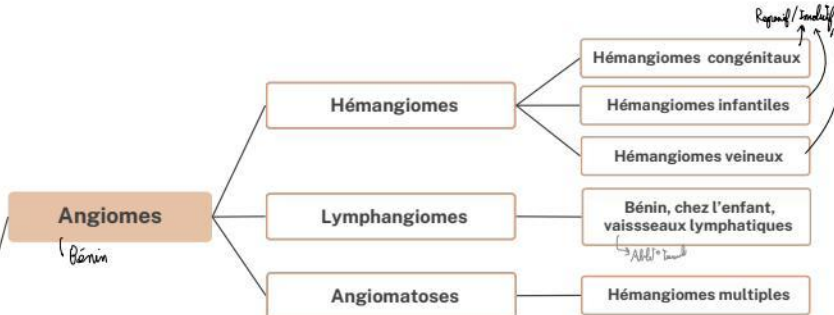
Amplification de MDM2

Ubiquitine P53 → Répression

TUMEURS MUSCULAIRES



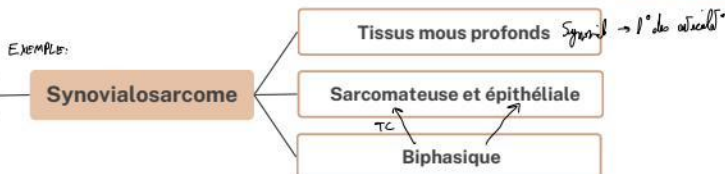
TUMEURS VASCULAIRES



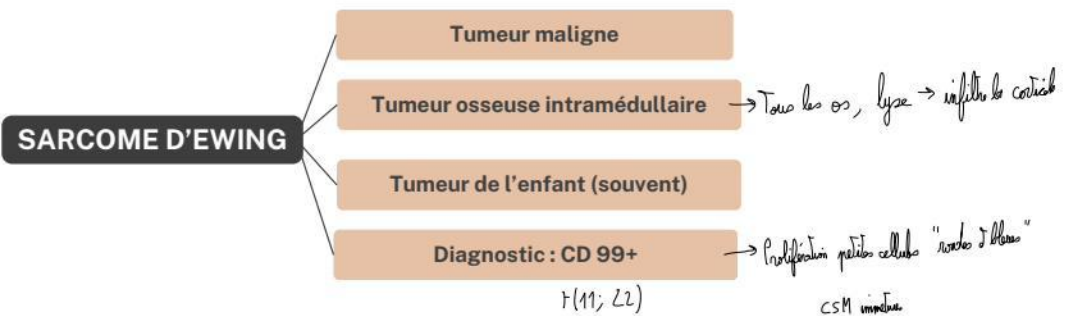
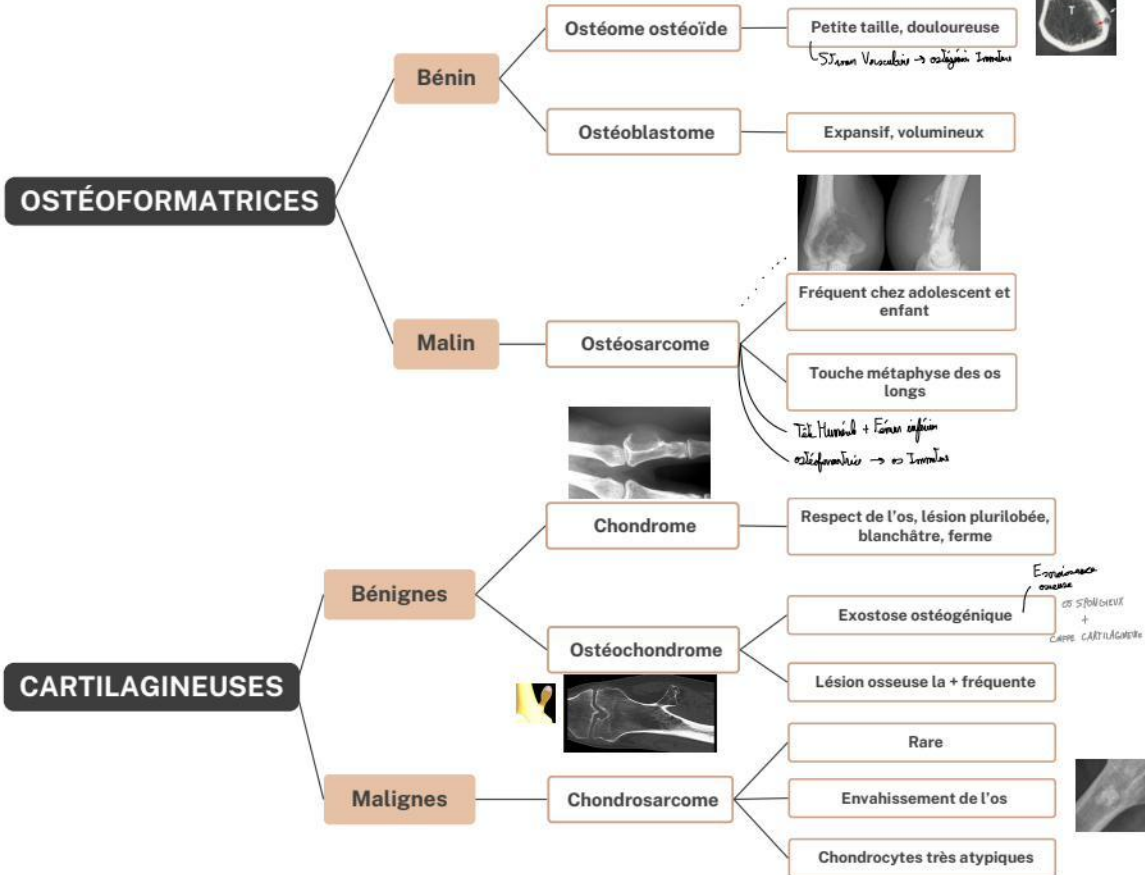
Kaposi's sarcoma



TUMEURS DE DIFFÉRENCIATION INCERTAINE



Exemple :

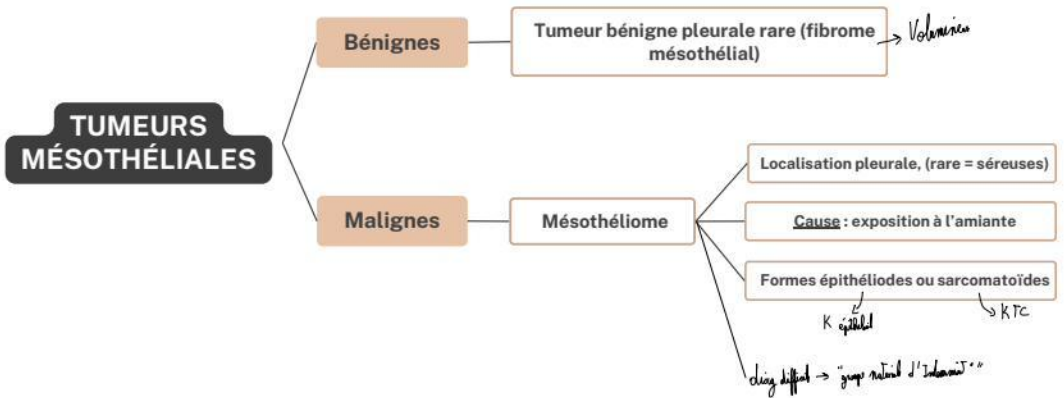


I.H.C: Immunohistochimie

10

Tumeurs mésothéliales

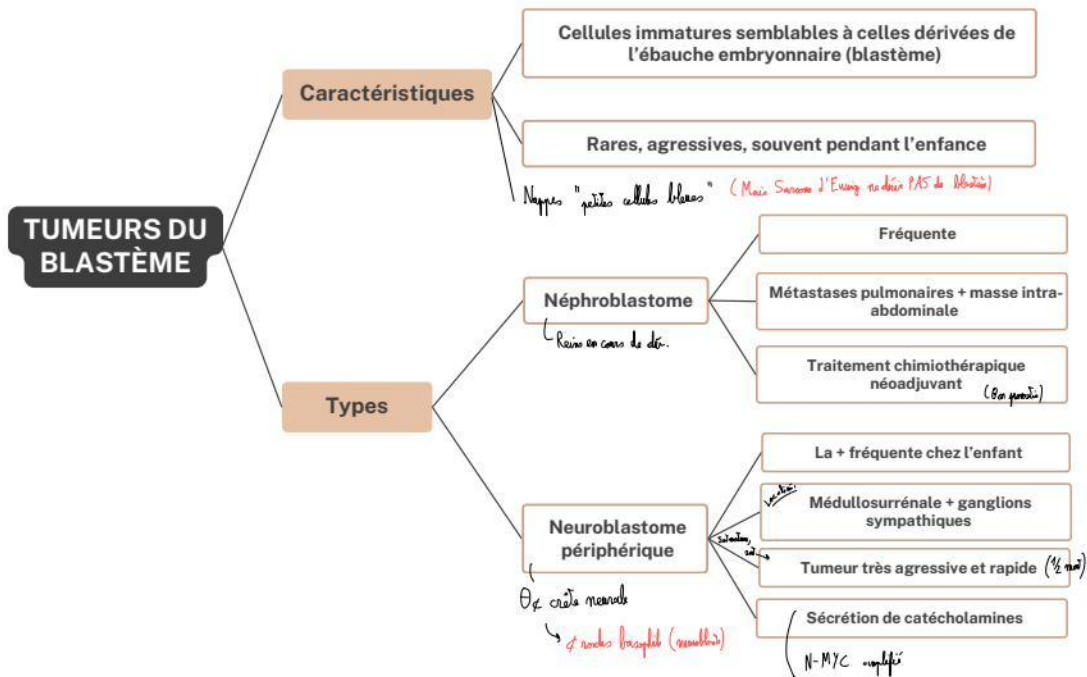
— Pleur / Pér / Péric



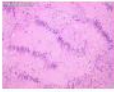
11

Tumeurs du blastème

→ Rare & complexe
→ Tumeur embryonnaire indifférenciée
"tumeurs embryonnaires"



Blastème = cellules transitoires qui sont encore indifférenciées et essentielles pour le développement de l'embryon, mais qui doivent normalement disparaître à la fin de la grossesse



TUMEURS NERVEUSES PÉRIPHÉRIQUES

Bénin

Schwannome
(= neurinome)

Nerf crânien (acoustique)

schwannome

Nerf périphérique

Maladie de Visceral: atrophie des nerfs

Cellules conjonctives de type fibroblastiques + cellules de Schwann

Compiquant une maladie de Recklinghausen (*neurofibromatose*)

Neurofibrome

+ Homogène SCHWANN

Maladie de Recklinghausen

Maladie de Recklinghausen

Maladie de Recklinghausen

Malin

Tumeur maligne des gaines nerveuses périphérique

Lésion maligne de haut grade

Lésion fasciculée avec cellules fusiformes atypiques

Neurofibromatose = maladie génétique non-tumorale à l'origine de multiples tumeurs nerveuses

NF 1: Trisomie "Coffin-Loslier" - Neurofibromatose

NF 2: Neurofibromatose Acoustique

NF 3: Neurofibromatose Périsphérique



TUMEURS CÉRÉBRALES PRIMITIVES

Extra-parenchymateuse

Méningiome ou autres tumeurs conjonctives (rarement)

Prolifération méninge

Tissu glial de soutien

Gliome circonscrit

Astrocytome pilocytique

Moins agressif

2 gènes

(NF1, NF2 + NF3)

Gangliogliome

T. crânienne "chorioépithéliome"

Gliome diffus

Astrocytome diffus

Astro. anaplasique

→ 2 gènes + NF3

Oligodendrogliome

Oligo. anaplasique

→ 2 gènes

Glioblastome

T. la plus agressive

Eléments péri ou intraventriculaire

Épendyme

Tumeurs des plexus choroïdiens

Intra-parenchymateuse

Tumeur neuronale ou glio-neuronale

Tumeur embryonnaire

Médulloblastome (cérébelleux)

cervelle

Neuroblastome (hémisphérique)

cerveau

Cellules Germinales Totipotentes

△ Trois sous-classes de cellules germinales

Séménos

↳ Tumeurs de 1^{er} grade

CD 119 + PLAP

↳ Dysgerminoma (ovaire)

Germénome (ovaire central)

Tissus Embryonnaires

Epithélium

Cancerose Embryonnaire

↳ ≠ épithélium peu différencié

↳ CD30

ECB/Mes/Endodermes

Ténotomes (3 types)

↳ 1^{er} type... Chénost, dent.

matrice + fibres / muscles + muscles

Tumeurs

Embryonogénitales

Vésicules Vitrines

↳ Sécrète Protéine (SMA)

Trophoblastes

Choriocarcinome

↳ Amnios Embryon (Placenta)

↳ β-HCG

Cellules Normales

Série de amplification

Cellule Tumorale

Chromosom ("accidents")

Proto-oncogènes (signaux normaux) → Oncogènes (dysfonction, normal)

RAS activé activé

MYC Sur Expression

↳ Anti-oncogènes ("frein supprimeur de tumeur")

RB "Protéine du Retard" → Séquence E2F

dJ 13q14

↳ P53 signale les mutations

↳ Gènes Mutation Intégrés

MSH2, MSH6 → Mismatch Appairage ADN (MMR)

BRCA1 → Répare l'ADN, casse double brin (HR: Homologous Recomb)

↳ X-Sais / ovaires

BCL-2: Anti-apoptotique

Telomérases: Prolifération illimitée

Syndrome Li-Fraumeni: Prolifération de X ou P53 mutée

Anomalies génétiques

Amplification

Méthylgène (CG)

5'-méthylgène

Translocation

Translocation



Méthodes de détection: Sondes Break-Apart

ADN Sais

Sais 1

Sais 2

ADN Tumorale

Sais 1

Sais 2

2 Sais 2 jours

1 Sais 2 jours en 0

Sondes de Fusion

ADN Sais

Sais 1

Sais 2

ADN Tumorale

Sais 1

Sais 2

Pas de fusion

1 fusion = 1 Translocation

Thérapie ciblée: médicaments qui ciblent les protéines

↳ Facteurs de croissance

Protéine Récepteur

↳ Facteurs de croissance

Sélective à l'impact/facteur protéique

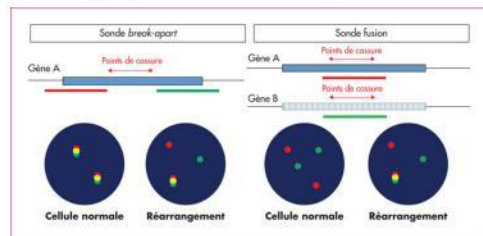
Score HER2	0	1+	2+	3+
Statut HER2	Négatif	Négatif	Incertain	Positif

HER2 négatif

HER2 positif

Herceptin (trM) ...

HER2 = Erb B2 = EGF Récepteur 2



Anomalies "externes"

Facteurs Viraux

HTLV 1

Facteurs Physiques

UV

Facteurs Chimiques

Tobac, Alcoolisme